

KC桌面——外资精译

中国生物科技 | 亚太

ASCO 2026 要点速览 - 第二天

核心要点

第二天转向更广泛的一线进展，尤其是关于RAS/ADC在方案设计、剂量强度、生活质量以及疗效/毒性权衡方面的讨论。KRAS G12C单药疗法看起来仍是更清晰的一线方案；联合疗法的疗效是真实的，但需要更严格的PD-L1/共突变/CNS筛选、不良事件管理和剂量连续性。仅凭机制可能无法定义G12C的持久性：ON/OFF通读仍不明确，而分子水平的PK、结合、CNS和毒性可能差异很大。非G12C和泛RAS使得RAS图谱充满变数；化疗为主的路径、MAPK伙伴、谱系可塑性以及皮肤/GI生活质量毒性仍是一线治疗中需要关注的制约因素。

中国视角：RAS对Abbisko/Genfleet/Jacobio的影响；ADC的讨论倾向于Duality/Innovent/Akeso/Leads Bio在格式深度、载荷/连接子及联合逻辑方面的优势。

KRAS G12C NSCLC：Divarasib和Elisrasib的数据支持一线单药/联合疗法的潜力。讨论者对单药疗法更有信心；联合疗法的疗效是真实的，但使用可能需要细分选择性（PD-L1/共突变/CNS）和主动的GI/肝脏不良事件管理。讨论者认为，鉴于化疗的长期生存获益有限，纯化疗联合方案的可能性低于+IO +/-化疗。她强调“并非所有G12C抑制剂都一样”，存在分子差异和（ON）与（OFF）通读的不确定性，因为一些（OFF）药物显示出持久的单药活性。肝毒性/剂量调整仍是关键。

非G12C/泛RAS：一线探索仍在各种机制中推进。PDAC联合方案主要基于化疗，而未来的研究可能会阐明MAPK/其他伙伴和谱系可塑性。鉴于对生活质量的影響，皮肤/GI毒性是关键。

ADC：在UC、TNBC和HER2+ BC中倡导一线使用，重点关注联合疗法与序贯疗法以实现可耐受给药。双载荷/双特异性ADC被强调为下一波创新，特别是超越拓扑异构酶/微管蛋白的载荷；连接子稳定性、生物标志物依赖性和交叉耐药性是值得关注的问题。



图表 1



图表 2

中国医疗健康